



FUNDAMENTOS

de la

NEURODIVERSIDAD

Lic. Natalia Escalante



CONTENIDOS

Introducción a la
Neurodiversidad y la
Inclusión

¿Qué es la
neurodiversidad?

Principales perfiles
neurodivergentes

Mitos y
realidades

NEURODIVERSIDAD

La neurodiversidad reconoce que las diferencias en el funcionamiento cerebral forman parte de la variabilidad natural humana. Este enfoque propone pasar de un modelo patologizante a uno inclusivo, que valora las fortalezas cognitivas y promueve la adaptación de los entornos educativos para garantizar la participación de todos.



NEURODIVERSIDAD

- Trasciende la concepción tradicional de la diversidad humana.
- Valora las variaciones naturales en el funcionamiento neurológico y cognitivo de las personas.
- Variación biológica y no patología.
- El término fue acuñado por la socióloga Judy singer.



LA INCLUSIÓN EDUCATIVA

Derecho a una educación de calidad sin discriminación.

Eliminación de Barreras para el Aprendizaje y la Participación (BAP).

Atención a la diversidad mediante adaptaciones y apoyos.



DIFERENCIA ENTRE DIVERSIDAD Y DISCAPACIDAD

Diversidad



La diversidad reconoce que no existe una única forma "correcta" de aprender, pensar o comunicarse.

las variaciones en el funcionamiento cerebral (como el autismo, TDAH o dislexia) son consideradas parte de la diversidad humana y no necesariamente un déficit.

Discapacidad



La discapacidad surge cuando el entorno no ofrece los apoyos o ajustes necesarios para garantizar la participación.

Según la Clasificación Internacional del Funcionamiento (CIF) de la OMS, la discapacidad no depende únicamente de la condición de la persona, sino también del contexto en el que se desarrolla.

MODELOS TRADICIONALES VS ENFOQUE INCLUSIVO

El modelo tradicional (también llamado modelo médico o deficitario) considera que las dificultades se encuentran principalmente en la persona. El objetivo suele ser corregir, rehabilitar o normalizar aquello que se percibe como una deficiencia.



MODELOS TRADICIONALES VS ENFOQUE INCLUSIVO

El enfoque inclusivo reconoce que las personas son diversas y que las barreras suelen encontrarse en el entorno. Busca transformar los contextos para garantizar la participación, el aprendizaje y el bienestar de todos.



Modelo Tradicional vs. Enfoque Inclusivo

MODELO TRADICIONAL (Modelo médico / deficitario)		ENFOQUE INCLUSIVO (Modelo social / de derechos)	
	El problema está en la persona.	 ENFOQUE	Las barreras están en el entorno. 
	Se enfoca en déficits y limitaciones.	 PERSPECTIVA	Se enfoca en fortalezas, potencialidades y apoyos. 
	La persona debe adaptarse al sistema.	 RESPONSABILIDAD	El entorno también se adapta. 
	Promueve segregación o atención diferenciada.	 PARTICIPACIÓN	Promueve participación, pertenencia y comunidad. 
	Busca normalizar y corregir.	 OBJETIVO	Busca incluir, valorar la diversidad y eliminar barreras. 
 Ejemplo Un estudiante con TDAH es visto como un alumno problemático que debe modificar su comportamiento para adaptarse a la clase.			Ejemplo Un estudiante con TDAH recibe apoyos visuales, instrucciones claras y pausas activas para favorecer su participación y aprendizaje. 

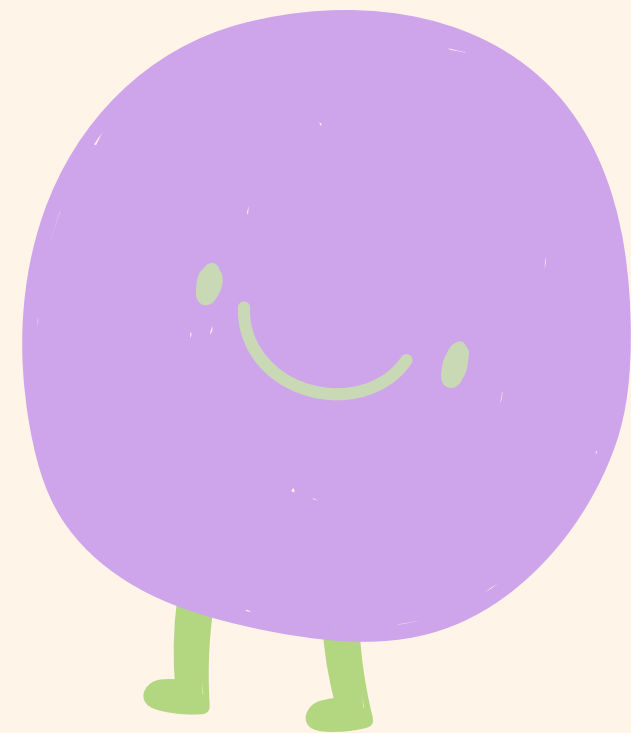


Mensaje clave: Mientras el modelo tradicional pregunta “¿qué le pasa a esta persona?”, el enfoque inclusivo pregunta “¿qué barreras debemos eliminar para que participe plenamente?”.



PRINCIPALES PERFILES NEURODIVERGENTES

- Trastorno del Espectro Autista
- TDAH
- Dislexia
- Dispraxia



TROSTORNO DEL ESPECTRO AUTISTA

Según el DSM-5 (2014), esta condición se diagnostica y califica según los siguientes criterios diagnósticos:

A. Dificultades persistentes en la comunicación social y la interacción social, pudiendo presentar las siguientes características:

- Deficiencias en reciprocidad emocional
- Deficiencias en comunicación no verbal
- Deficiencias en cuanto al desarrollo, mantenimiento y comprensión de las relaciones sociales.

TROSTORNO DEL ESPECTRO AUTISTA

B. Comportamientos, intereses y actividades restrictivas y repetitivas, pudiendo presentar dos o más de las siguientes características :

- Movimientos, uso de objetos y habla estereotipados.
- Excesiva inflexibilidad, monotonía y rituales de comportamiento.
- Intereses restringidos peculiares respecto de su intensidad o foco de interés.
- Hiper o hiporreactividad a estímulos sensoriales.

TROSTORNO DEL ESPECTRO AUTISTA

C. Los síntomas están presentes en las primeras fases del desarrollo

D. Los síntomas afectan significativamente el desempeño social, laboral entre otros.

E. Estos síntomas no se explican por un retraso global del desarrollo o una discapacidad intelectual. No obstante, el TEA y la discapacidad intelectual pueden convivir.

TRASTORNO POR DÉFICIT DE ATENCIÓN E HIPERACTIVIDAD

- Trastorno del neurodesarrollo con síntomas relacionados a la desatención, hiperactividad e impulsividad.
- Presentan dificultades en el funcionamiento en la escuela, en la familia y en las relaciones sociales.
- Afecta entre el 8% a 12% de los niños de todo el mundo.





TRASTORNO POR DÉFICIT DE ATENCIÓN E HIPERACTIVIDAD

SEGÚN EL DSM-5, se deben cumplir seis o más de los criterios de inatención, los cuales deben presentarse por al menos seis meses:

- • Dificultad para prestar atención a detalles ocasionando errores.
 - • Dificultad para centrar la atención en actividades recreativas.
 - • Aparenta no oír cuando se le dice algo.
 - • Rechaza actividades que requieren concentración
 - • Usualmente pierde materiales importantes.
 - • Usualmente no recuerda las actividades cotidianas.
 - • Usualmente olvida las actividades cotidianas.
 - • Usualmente se distrae fácilmente con estímulos externos.
- 

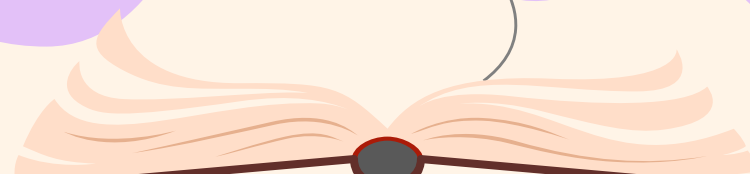
TRASTORNO POR DÉFICIT DE ATENCIÓN E HIPERACTIVIDAD

SEGÚN EL DMS-5, deben manifestarse seis o más de los criterios de hiperactividad e impulsividad por un periodo no menor a seis meses:

- Juega con sus manos y se retuerce en su sitio.
- Se para de su sitio en ocasiones inapropiadas.
- Corre o trepa en ocasiones inapropiadas.
- No se integra de forma tranquila en actividades recreativas.
- Pareciera que lo “controla un motor” o está siempre “ocupado”
- Presenta un habla excesiva.
- Al hablar no espera turnos o interrumpe.
- Dificultad para esperar turnos.
- Interrumpe actividades de otros.

DISLEXIA

La dislexia es un trastorno específico del aprendizaje de origen neurobiológico que afecta principalmente la precisión, fluidez y comprensión lectora, así como la ortografía, pese a que la persona posee inteligencia adecuada y oportunidades de aprendizaje suficientes.



DISLEXIA

Su dificultad se encuentra en la automatización de las reglas de conversión grafema fonema.

Características:

- Dificultad para reconocer palabras con precisión.
- Lectura lenta o con errores frecuentes.
- Problemas en la decodificación y conciencia fonológica.
- Dificultades ortográficas persistentes.



DISPRAXIA

La dispraxia es una condición del neurodesarrollo caracterizada por dificultades significativas en la planificación, organización y ejecución de movimientos motores, afectando actividades cotidianas, académicas y sociales.



DISPRAXIA

Características principales:

- Torpeza motriz.
- Dificultad para escribir, recortar o abotonarse.
- Problemas de coordinación y equilibrio.
- Lentitud para aprender nuevas habilidades motoras.



MITOS Y REALIDADES

Mito 1: "La neurodiversidad es una enfermedad"

Realidad: La neurodiversidad es un paradigma que reconoce las diferencias neurológicas como parte natural de la diversidad humana. No se refiere a una enfermedad, sino a distintas formas de pensar, aprender, comunicarse y percibir el mundo.



MITOS Y REALIDADES

"Todas las personas neurodivergentes son iguales"

Realidad: Existe una gran variabilidad dentro de cada perfil neurodivergente. Dos personas con TEA, TDAH o dislexia pueden presentar fortalezas, desafíos y necesidades de apoyo muy diferentes.



MITOS Y REALIDADES

Mito 3: "La inclusión significa bajar el nivel académico"

Realidad: La inclusión busca eliminar barreras y ofrecer apoyos adecuados para que todos los estudiantes participen y aprendan, manteniendo altas expectativas para cada persona.



ESTIGMAS FRECUENTES

Estigmas comunes en neurodiversidad

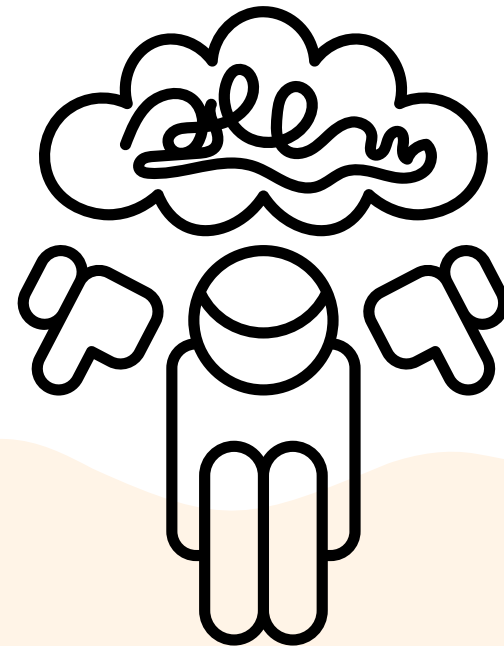
- "No quieren relacionarse con los demás."
- "Son problemáticos o difíciles."
- "Nunca podrán ser independientes."
- "Exageran sus dificultades."
- "Necesitan ser tratados como niños."



ESTIGMAS FRECUENTES

Consecuencias de los estigmas

- Baja autoestima.
- Exclusión social.
- Menor participación escolar.
- Barreras para acceder a apoyos.
- Problemas de salud mental asociados al rechazo social.



LENGUAJE INCLUSIVO

¿Por qué es importante?

El lenguaje influye en la manera en que percibimos y tratamos a las personas. Un lenguaje respetuoso favorece la inclusión y reduce la estigmatización.



LENGUAJE INCLUSIVO

Recomendaciones

Utilizar:

- Persona autista / persona con autismo (según preferencia individual).
- Persona neurodivergente.
- Características o rasgos.
- Necesidades de apoyo.

Evitar:

- "Sufre de autismo."
- "Padece TDAH."
- "Normal" vs. "anormal."
- "Alto funcionamiento" o "bajo funcionamiento" como únicas descripciones.

¡MUCHAS GRACIAS!